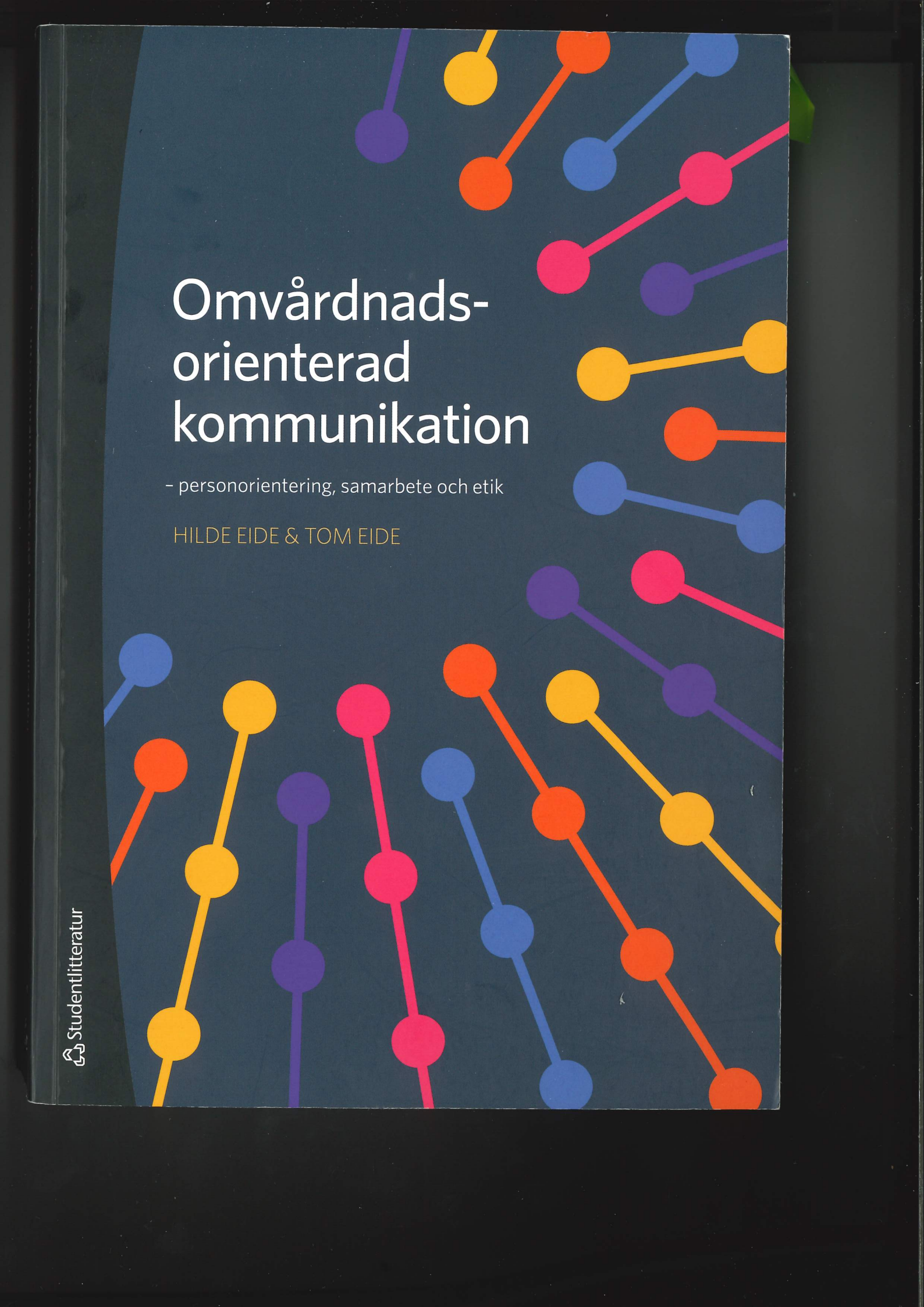


The background of the book cover is a dark blue-grey color. It is decorated with numerous thin, straight lines in various colors (yellow, orange, pink, blue, and purple) that connect circular dots of the same color. These lines and dots are scattered across the entire cover, creating a network-like or molecular structure. The title is printed in a clean, white, sans-serif font.

Omvårdnads- orienterad kommunikation

– personorientering, samarbete och etik

HILDE EIDE & TOM EIDE

Nu närmast ska vi gå in på hur ett samtal kan struktureras. Kanske är det inte självklart varför detta är så viktigt. Men om vi ser situationen ur patientens perspektiv, kan ett ostrukturerat samtal ofta upplevas oförberett och otillfredsställande. En bra struktur signalerar respekt för den andre, visar att man är förberedd, gör det lättare att komma fram till ett bra resultat och – inte minst – pekar det framåt i tiden. Har man en bra struktur på samtalet är det också lättare att lyssna aktivt.

Att strukturera ett samtal

Samtalets tre delar

Samtal kan vara planerade eller uppstå spontant, vara korta eller långa, känslomässigt neutrala eller starkt emotionella. Samtalssituationer kan vara mycket olika och ha olika naturliga förlopp. Oavsett vilket slags samtal det handlar om har bra professionella samtal ofta en enkel tredelad struktur:

- 1 inledning
- 2 kärna
- 3 avslutning.

En sådan tredelning verkar kanske självklar, men i praktiken visar det sig att det att öppna och avsluta samtal på ett bra sätt förutsätter både förberedelse och en vaken blick för det som i det professionella perspektivet är det väsentliga. Att strukturera ett samtal med en patient eller en anhörig går ofta inte av sig självt. Det är en komplex och ibland krävande uppgift som också vårdpersonal med lång erfarenhet kan behöva tänka igenom och träna på med jämna mellanrum.

Vi börjar med att tänka oss följande dialog mellan sjuksköterskan Lotta och patienten Erik, som ska in till en stor hjärtoperation:

- LOTTA (på väg in, munter): Gomorron Erik, står det bra till i dag?
ERIK (orolig, trött, har mörka påsar under ögonen efter en sömnlös natt): Jo ...
LOTTA (avbryter, med ett leende): Det var fint. Och läkaren har informerat dig om allt kring operationen?
ERIK (ängslig, tvekande): Ja, jag ...
LOTTA (på väg ut): Bra! Då är det inte mer som behöver göras här. Då får vi bara hoppas att operationen går bra då, Erik. Lycka till!

Exemplet
inte är me
positiv, m
har det. H
informera
förmodlig
för god k
och avslut
De stru
kan illust
samtal m

Observation

Vad obser

Inledning

- Hälsar o
- En ledig
- Bestäm

Följer upp

- Vilka a
- Vilka te
- Vilka k

Bekräftar

- Använd
- Omform
- Tolkar
- Spegla

Styr och s

- Håller
- Tar upp
- Ger inf

Icke-verb

- Är öpp
- Är någ
- Är fok
- Använd
- Emotio

Avslutning

- Låt de
- Bekräft
- Gör öv
- Säger

Exemplet är något karikerat, och man ser genast att sköterskan Lotta inte är mentalt närvarande hos patienten Erik. Hon är förvisso glad och positiv, men hon lyssnar inte på honom, och observerar inte heller hur han har det. Hon försvinner ut utan att förvissa sig om att han är tillräckligt informerad, och utan att han har fått möjlighet att ta upp de frågor han förmodligen har. Lotta bryter mot de flesta grundläggande principerna för god kommunikation, även mot principerna för hur man bör inleda och avsluta ett samtal.

De strukturerande och kommunikativa utmaningarna i de olika faserna kan illustreras med observationsschemat. Det utarbetades ursprungligen för samtal med klienter på ett socialkontor och vidareutvecklades senare för

Observationsschema

Vad observeras	Anteckningar
<i>Inledning av samtalet</i> • Hälsar och presenterar sig • En ledig och varm introduktion • Bestämmer tillsammans vad samtalet ska syfta till	
<i>Följer upp patientens antydningar och angelägna frågor</i> • Vilka antydningar • Vilka teman • Vilka känslor	
<i>Bekräftar och möter patienten</i> • Använder samma ord • Omformulerar • Tolkar • Speglar känslor	
<i>Styr och strukturerar samtalet</i> • Håller sig till ämnet för samtalet • Tar upp de viktiga temana • Ger information och förklaringar vid rätt tidpunkt	
<i>Icke-verbal kommunikation</i> • Är öppen och varm • Är någorlunda avslappnad • Är fokuserad på patienten • Använder beröring • Emotionell ton	
<i>Avslutning av samtalet</i> • Låt den andre sammanfatta • Bekräftar, eventuellt fyller i eller justerar • Gör överenskommelser/vidarebefordrar kontakt • Säger adjö/nej då	

samtal med patienter.⁵ Här har vi bearbetat och förenklat det något med tanke på observation av personorienterad kommunikation med patienter och anhöriga. Schemat ger en översikt över innehållet i samtalets faser och illustrerar samtidigt hur komplext ett samtal ofta är, och hur aktivt lyssnande ingår på olika sätt i olika faser av samtalet.

Har man en bra struktur och ram för samtalet är det också lättare att lyssna aktivt till den andre, samtidigt som hon eller han får lättare att känna sig trygg och väl respekterad.

Den här checklistan kan bland annat användas för observation under simuleringsträning och för att förbereda sig för och reflektera över egna verkliga patientsamtal.

Nu ska vi gå närmare in på vad samtalets tre delar kan innehålla.

Inledningen

Fem huvudfunktioner

Alla samtal är olika – och de kan ha olika syfte. Ofta gemensamt är att inledningen av samtalet ska etablera relationen, skapa tillit och trygghet och klargöra syftet med samtalet. Öppningen skapar en ram för anknytning och kan vara helt avgörande för det fortsatta förloppet.

Öppningen har också ofta som funktion att tydliggöra förutsättningarna för samtalet, om dessa inte redan är klara, och att starta processen med att formulera vad samtalet ska handla om, vilket eller vilka problem som ska diskuteras.

Om samtalets syfte är att hjälpa patienten att utforska och tänka igenom sin situation, kommer förutsättningen vara att patienten själv ska reflektera. Därför är det viktigt att skapa en öppen samtalssituation. Om syftet med samtalet däremot är att ge information och hjälpa patienten att finna sig tillrätta kommer förutsättningen vara att ramarna är satta, och att sjuksköterskan tar sikte på att hjälpa patienten till att få översikt och kontroll över sin egen situation.

Vi kan med detta säga att öppningen kan ha fem huvudfunktioner:

- 1 att etablera relationen
- 2 att skapa kontakt och trygghet
- 3 att klargöra ramarna för samtalet (tid, plats och syfte)
- 4 att starta probleminventeringen
- 5 att skapa en öppen samtalssituation.

⁵ Silverman et al., 2016.

Att etablera relationen

Det första mötet och inledningen på samtalet har stor betydelse också av den anledningen: både vi och den andre kommer att ha en spontan tendens att reagera utifrån stereotypa uppfattningar. Patienten skapar sig en bild av vårdaren i skärningspunkten mellan det första intrycket och sina stereotypa uppfattningar som är knutna till exempelvis profession, kön, ålder, hudfärg och utseende. Hur vårdaren inleder mötet kan därför vara avgörande som ett korrektiv till eller bekräftelse av patientens stereotypier. Har patienten en bild av sjuksköterskor som auktoritära och griniga kan det vara bra att få den uppfattningen modifierad i det första mötet, exempelvis genom att sjuksköterskan är vänlig, lyssnande och tar god tid på sig. Om patienten har en bild av sjuksköterskor som omsorgsfulla och hjälpsamma kan det vara bra att få detta bekräftat redan vid den första kontakten.

Att skapa en arbetsallians

En viktig kommunikativ uppgift för vårdaren är att skapa en *arbetsallians*. Begreppet arbetsallians kommer ursprungligen från psykoanalytisk terapiforskning,^{6 7} men har efterhand fått en bredare användning i hälso- och omsorgsarbete. Arbetsalliansen förutsätter god kontakt och en viss anknytning, en ömsesidig positiv inställning och tillit mellan vårdpersonal och patient, samt motivation för att samarbeta om att uppnå gemensamma mål. Arbetsalliansen omfattar också den uppsättning avtal som ingås mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten, bland annat om mål, tillvägagångssätt och ansvarsfördelningen mellan de två.⁸

Psykoterapiforskningen har visat att det finns ett samband mellan en god arbetsallians och bra behandlingsresultat.⁹ Relationens betydelse för resultatet har också dokumenterats inom andra områden av människovårdande arbete.^{10 11 12 13}

För att du ska kunna bygga upp en god arbetsallians är det viktigt att du lyssnar till vad den andre har att säga, möter henne eller honom med respekt och visar att både du och institutionen du arbetar inom går att lita på. Patienten måste kunna lita på att överenskommelser hålls, att rutiner följs

6 Bordin 1979, 1983, 1994.

7 Horvath & Greenberg, 1984.

8 Wampold & Imel, 2015.

9 Ibidem.

10 Nerdrum, 2000.

11 Shattel, 2004.

12 Street et al., 2009.

13 Wiechula et al., 2015.

och att man får den hjälp och det stöd man bett om och kommit överens om. Det skapar anknytning, trygghet och tillit, förutsättningar för att kunna förstå personens hälsoprojekt och kunna samarbeta om och medverka till ett möjligt resultat.

Det konkreta målet för omvårdnad och behandling kan ha mycket olika karaktär. Patientens projekt kan vara att bli frisk fortast möjligt, allra helst genom självhjälp, oberoende av vårdpersonal och annan hjälp. När det gäller allvarligt sjuka och döende är trygghet och lindring av smärta och lidande centrala mål. I andra situationer kan målet vara att bli lite bättre, bromsa sjukdomsförloppet eller att lära sig leva på bästa möjliga sätt med smärtor, skador eller andra begränsningar av livskvaliteten. Gemensamt är emellertid att kommunikation är ett medel för att utveckla

- en god arbetsallians
- en gemensam förståelse av problem och mål
- ett så bra samarbete som möjligt mellan vårdare och patient för att nå de mål man sätter upp gemensamt.

Skapa kontakt och trygghet

I den första fasen, som omvårdnadsteoretikern Peplau¹⁴ kallar för orienteringsfasen, läggs alltså grunden för kontakten och tryggheten mellan vårdaren och den andra människan. (Mer om Peplau i kapitel 14, *Tankarna bakom*.) Vårdaren och den andre är kanske fortfarande främmande för varandra, men börjar så småningom att skapa sig mer nyanserade uppfattningar om vem den andre är som person. Genom att möta en annan människa med lyssnande öppenhet och med klar och tydlig information går det snabbare att etablera kontakt och få kunskap om vad den människan har behov av.

En utmaning för vårdpersonal är att i den här fasen se patienten som en person och inte som ett objekt. Som vårdare kan man exempelvis ha en tendens att behandla personer med samma sjukdom mer likartat än vad situationen och tillståndet kräver. Människan blir reducerad till ett fall. När Travelbee¹⁵ föreslår att man ska överge patientbegreppet och hellre använda begreppet "person" är det ett försök att hitta en lösning på problemet. Men man kommer knappast att lösa problemet genom att ändra begreppet. Tendensen till reduktionism är något var och en gång på gång måste upptäcka och ta ställning till hos sig själv.

Hur bör man då inleda det första samtalet med patienten? Det går knap-

¹⁴ Peplau, 1952.

¹⁵ Travelbee, 1971, 1999.

past att utfärda något enkelt och entydigt recept. Patienter är olika. Men några enstaka elementära moment kan vara bra att påminna sig om.

De flesta patienter är i en situation som de inte har valt och inte vill vara i. Sjukdom och försvagning är alltid en belastning (se kapitel 2, *Coping och motivation*). Ofta känner sig patienten osäker, svag och kanske också förvirrad. Vissa känner också skam över att vara sjuk eller i behov av hjälp. Säkerligen finns det också de som söker sig till patientrollen. Men oavsett vilka skälen är har patienten vissa grundläggande behov och rättigheter som bör uppfyllas i det första mötet:

- att bli mött med respekt och hövlighet
- att bli lyssnad på
- att få klar och riktig information.

Det kan kanske uppfattas som så självklart att det inte behöver nämnas en gång till. I praktiken ser vi emellertid ofta hur de här elementära kraven inte blir tillgodosedda.

Samma normer gäller för patientbehandling som i umgänge med andra personer: att man är artig och bemöter den andre med respekt. Det enda naturliga och självklara sättet att inleda det första mötet på är därför att ta i hand, hälsa och presentera sig med hela sitt namn. Det kan också vara viktigt att kort informera om vilka roller man har, så att ramen för relationen blir så tydlig som möjligt.

Att presentera sig med hela sitt namn och sin tjänsteställning gäller för övrigt också för telefonsamtal.

Klargöra ramarna

Sjuksköterskan förbereder sig ordentligt inför det första samtalet med patienten. En viktig del av förberedelsen är att göra klart för sig själv vilka *mål* man har med samtalet. Man går igenom anteckningar, omvårdnadsplaner och journaler, skaffar sig annan relevant information och anpassar det hela i praktiken. Om möjligt bör man också komma överens med patienten på förhand om tid och plats för samtalet och gärna klara ut om anhöriga ska vara med eller inte. Det är viktigt att samtalet äger rum i en lokal där man kan tala ostört.

I samtalet presenterar vårdaren klart och tydligt ramarna för samtalet. "Välkommen hit! Jag heter Gréte Hansson och är sjuksköterska. Jag ska följa med dig upp på avdelningen, som ligger en trappa upp. Där ska du få prata med Per André, som också är sjuksköterska. Det är han som kommer att ha ansvaret för dig medan du är här. Just nu är han upptagen med lite annat,

men han kommer vilket ögonblick som helst. Han kommer att berätta något om vad som ska hända i dag, och du kan prata med honom om sådant som du kanske funderar på.”

Beroende på vilket slags samtal det handlar om kan det vara bra för patienten att redan från början få kännedom om tider, platser, personer och procedurer. Det kan också gälla eventuella dags- och veckoplaneringar och information om hur patienten själv och eventuella anhöriga ska förhålla sig, och vad som förväntas från vårdarens och institutionens sida. Avsikten är att patienten ska få överblick, information och en känsla av att ha kontroll. Att klargöra ramarna kan med fördel göras i dialogform, så att patienten har möjlighet att ställa frågor om det som verkar oklart. Alltför mycket detaljinformation kan dock skapa förvirring, så det gäller att lyssna till vad patienten har behov av och hitta en rimlig balans.

Att klargöra tidsramen kan vara lämpligt av flera skäl. Gott om tid är ingen nödvändig förutsättning för ett bra samtal. En erfaren vårdare kan uträtta mycket på fem-tio minuter. En begränsad tidsram kan bidra till att samtalet koncentreras på det som är väsentligt, både för patienten och vårdaren.

Poängen med att fastställa tidsramen är inte främst att minska tidsåtgången. Det skapar en ram som gör att man fokuserar på det som är väsentligt. Om tidsramen är otydlig, kan samtalet lätt flyta ut. Om man som vårdare har ont om tid och inte fastställer tidsramen kan man lätt bli otålig och börja tänka på allt annat som också måste göras – och det märker patienten!

Dessutom kan patienten lätt känna sig lurad om vårdaren måste gå innan hon eller han har kommit fram till poängen. Om man kommit överens om tidsramen är även patienten ansvarig för att använda tiden till att tala om det som hon eller han har på hjärtat.

Att tydliggöra tidsramarna skapar ofta snabbare och bättre kontakt, bidrar till att man använder tiden effektivt och är därför ett bra hjälpmedel till en god och tillfredsställande behandling. Om man har så lite tid att man inte hinner med mycket mer än att hälsa kan man i stället avtala en ny tid då man kan prata, som i det här exemplet:

- PER Hej, jag heter Per André. Jag är sjuksköterska, och det är jag som har ansvaret för dig här i dag. Jag skulle vilja att vi kan prata tillsammans, så att jag kan ge dig den information du behöver, och så att du kan berätta för mig det jag behöver veta för att kunna planera vidare. Det var Karin Hansen, eller hur?
- KARIN Ja, det stämmer.
- PER Ja, välkommen hit. Jag har förstått att du är här för att ta bort gallblåsan.

- KARIN Ja, just det.
- PER I förbindelse med operationen och vistelsen här är det säkert en del saker du funderar över. Det skulle vara bra om du kunde berätta lite för mig om hur du har det, och hur du har uppfattat det du ska göra här. Men innan vi sätter igång, vill jag gärna avtala en tidpunkt med dig, så att vi har tid att prata. Jag har satt av 20 minuter senare i dag. Tror du att den tiden räcker?
- KARIN (*lite dröjande*): Njae, jag vet inte hur lång tid man behöver för ett sånt samtal, men det är säkert okej.
- PER (*märker att Karin drar lite på det*): Om det skulle visa sig att du behöver prata med mig om något som tar mer än 20 minuter, kan vi avtala en ny tid lite senare. Ska vi säga att jag kommer hit om en halvtimme, klockan 11?
- KARIN Det tycker jag låter bra.
- PER Är det något du vill fråga om nu på en gång?
- KARIN Nej, ingenting jag kommer på så här i all hast.
- PER (*väntar lite, tittar på henne*): Okej, då får vi talas vid klockan elva.

I exemplet presenterar sig sjuksköterskan utan att vara stel och formell. Han har tydliga mål för samtalet: att hälsa välkommen, etablera relationen och avtala nästa möte. Han har ont om tid, men skapar ändå det utrymme som är nödvändigt för att informera om det allra viktigaste, nämligen att han har ansvaret för henne och gärna vill tala med henne lite senare. Han tar också initiativet till att de avtalar en tidpunkt för detta.

Att börja identifiera problem

Beroende på vilket syftet med samtalet är kan det bli mer eller mindre aktuellt att i början identifiera de problem och frågor som patienten har. Överhuvudtaget är det viktigaste att ha ett öppet öra för vad patienten har på hjärtat.

Om man som vårdare vill leda samtalet i en viss riktning, ger man signaler om det. I exemplet ovan kommer probleminventeringen att äga rum i nästa samtal, så sjuksköterskan styr undan detta. Vi ser emellertid att han lyssnar till patienten ("tillräckligt med tid?") och kollar av om det är något hon funderar på ("Är det något du vill fråga om?", väntar lite), så att han kan snappa upp det, om det är något som brådskar. Per bekräftar överenskommelsen innan han går, något som är viktigt, eftersom patienter i det första mötet ofta befinner sig i en ovan miljö, utsätts för många intryck och lätt kan bli förvirrade.

Att skapa en öppen situation

I vissa samtal – till exempel rådgivnings- och handledningssamtal där en trygg relation redan har etablerats – kan det vara ändamålsenligt att skapa en öppen situation, det vill säga en situation där den andre inviteras till att prata om det hon eller han själv funderar över. Det kan göras genom att ställa en öppen fråga, exempelvis i början av samtalet "Vad vill du ta upp i dag?", "Hur har du det just nu?" eller "Vi har en halvtimme i dag. Vad vill du använda den tiden till?".

Att skapa en öppen situation kan verka enkelt, men är inte desto mindre en färdighet som de flesta behöver öva sig på innan de behärskar den.

En öppen situation skapas ofta genom att man ställer en fråga som börjar med ett interrogativt pronomen som "vad" eller "hur". Men den kan också skapas utan att man ställer en fråga. "Nu har vi 30 minuter, och det är upp till dig vad vi ska prata om." Även om ett sådant yttrande inte har formen av en fråga, ligger det ändå en öppen fråga implicit i det: "Vad vill du att vi ska prata om?"

Att skapa en öppen situation är en bra utgångspunkt för att etablera en relation, skapa trygghet och att påbörja processen med att identifiera problem. Följande exempel är hämtat från inledningen av ett samtal mellan den kvinnliga handledaren Sara och den manlige sjuksköterskestudenten Markus, som är ute på sitt projektarbete på en ungdomsklubb för att lära sig om missbruksförebyggande arbete. I dialogen är det alltså Sara som är i vårdarens roll.

"Nej, jag vet inte riktigt ..."

SARA Vad vill du prata om i dag? Som vanligt har vi en halvtimme.

MARKUS Nej, jag vet inte riktigt (*nej*). Jag trivs ganska bra, men det är lite oklart för mig vilket slags ansvar jag har (*mm*). Vad jag ska göra, liksom. Och så tror jag att ledarna sinsemellan inte är helt överens om hur saker och ting ska göras, och inte heller om vad som är mina uppgifter. Ja, och i går var det en ganska obehaglig situation, där jag inte riktigt visste (*mm*) ... nej, jag vet inte ... det är mycket jag skulle kunna prata om ...

Vi ser att Sara skapar en öppen situation genom att ställa en öppen fråga. Samtidigt utnyttjar hon tillfället att klargöra hur lång tid de har till sitt förfogande, något som understryker att det är Markus som har ansvaret för hur tiden används.

Den här kombinationen av öppen fråga och fast tidsram är produktiv.

Markus börjar genast tala om det som han funderar på, och det är inte ett utan flera problem. Därmed kan utforskandet börja.

Men vilket är viktigast? Vad ska vårdaren – i det här fallet handledaren Sara – uppmuntra studenten att gå vidare in på?

Kärnan

Sex huvudfunktioner

Samtalets inramning – inledningen och avslutningen – är viktig. Men det är kärnan, då man talar om det som det handlar om, som är den viktigaste delen av samtalet.

Samtal kan vara av väldigt olika karaktär, från enkla inskrivningssamtal till mer komplexa informations- och handledningssamtal. Många samtal kan ha karaktären av en diskussion, där patienten kommer till tals om sitt medan vårdaren lyssnar, ger information och bidrar till att frågor och problemställningar blir fördjupade och uppklarade. Allt efter samtalets typ och syfte kommer samtalet att ha en mer eller mindre öppen karaktär, och vårdaren kommer att ha uppgifter av olika slag:¹⁶

- att utforska problem/tema
- att förstå den andres perspektiv
- att låta den andre välja problem
- att hålla struktur i samtalet
- att utveckla relation och allians
- att förklara och informera.

Att utforska och försöka förstå

För att utforska ett problem och förstå den andres perspektiv krävs ett brett spektrum av färdigheter. För att hjälpa patienten att öppna sig och dela med sig av sina reflektioner kan det vara viktigt att

- uppmuntra henne eller honom att berätta
- lyssna aktivt
- ställa öppna frågor
- använda bekräftande färdigheter både verbalt och icke-verbalt
- spegla
- omformulera
- använda pauser och tystnad aktivt.

¹⁶ Jämför Silverman et al., 2016.

Det gäller att fånga upp icke-verbala signaler genom ansiktsuttryck, tonfall och kroppshållning, samt att uppfatta antydningar och bekymmer som kan säga något om vad patienten upplever som viktigt, men kanske inte har formulerat så tydligt. Det kan också vara viktigt att uppmuntra den andre att uttrycka och utforska känslor och hur dessa i övrigt hänger samman med den aktuella situationen. På så sätt kan man både bidra till att utforska problemet och själv få information om den andres tankar och känslor. Detta gör det lättare att förstå hennes eller hans perspektiv.

Vi kommer tillbaka till utforskande färdigheter i kapitel 5, *Icke verbal kommunikation*.

Även om samtalets kärna ofta med fördel kan få flöda lite fritt, utifrån vad patienten funderar på, kan det också vara en fördel om man utan att styra alltför mycket kan bidra till att hålla en viss struktur i samtalet. Till exempel gör man det genom att hjälpa den andre att välja det tema eller problem som hon eller han upplever som viktigast, och genom att följa upp en sak i taget.

Att låta den andre välja problem

Ett problem kommer sällan ensamt. När man har skapat en öppen situation, är det – som i exemplet nyss – ganska vanligt att den andre presenterar flera problem på en gång.

Ofta kan också de olika problemen ha trasslat in sig i varandra. Sådana gånger är det en uppgift för sjuksköterskan (handledaren) att dela upp (partializing), sortera och tydliggöra för den andre vilka olika problem det handlar om.¹⁷ Därefter överläter man till den andre att välja vilket problem som ska tas upp först.

Ordet "problem" kommer för övrigt från det grekiska verbalsubstantivet *proballein* som betyder att framkasta eller framlägga något. Ett problem är alltså i det här sammanhanget något som den andre lägger fram, direkt eller indirekt.

Det är alltså inte vårdaren, utan patienten som ska välja problemet. Det finns flera anledningar till detta.

Det viktigaste skälet är kanske att den andre själv är expert på sin egen situation. Den som har problemen är den som bäst kan känna var skon klämmer, och bäst kan bedöma vad hon eller han behöver och vill ha hjälp med. Detta har också att göra med respekt för den andra personens självbestämmanderätt.

Ett annat skäl är motivation. Om den andre själv väljer vilket problem

¹⁷ Shulman, 2003, 2016.

som sk
verad
Vi s
Marku
uppgift

"Jag kä
SARA

MARKU

Sara bör
blemställ
kan vara
perspekti
att Sara –
att priorit
Strukt
Sättet
fråga: "Va
eller "Hur
både för at
välja vad s
Också
sådan öppe
ter, och det
Men när ol

Problem

P1 P4
P3 P2

Figur 4.2 Att

som ska avhandlas först kommer hon eller han normalt att vara mer motiverad att arbeta med det, än om det är vårdaren som tar beslutet.

Vi ska gå tillbaka till situationen mellan handledaren Sara och studenten Markus och se hur den utvecklar sig. Markus tar upp en rad problem. Saras uppgift blir här att hjälpa Markus att välja vad de ska tala om.

”Jag kände mig bara så grön ... ”

SARA Du nämner flera saker: vilket ansvar du har, oklarhet om dina arbetsuppgifter, oenighet mellan ledarna, en obehaglig situation i går ... Det låter som fyra mer eller mindre olika problem. Ska vi kanske ta en sak i taget? Vad skulle du vilja börja med?

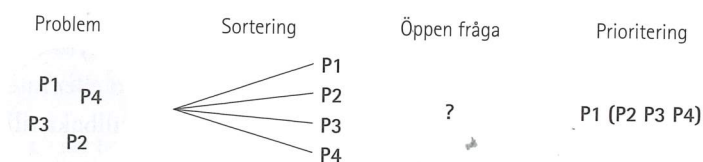
MARKUS (*suckar*): Nej, det jag tänker på, det är den där situationen i går, jag kände mig bara så grön, jag hade inte koll, liksom ... jag tror inte det där med att arbeta med ungdomar är någonting för mig ...

Sara börjar alltså med att sortera problemen och presentera de olika problemställningarna som hon ser dem för Markus. En sådan sammanfattning kan vara viktig i sig själv, eftersom den bidrar till att skapa distans och perspektiv, vilket den som presenterar problemen ofta saknar. Vi ser vidare att Sara – med en ny öppen fråga – klart och tydligt överlåter till Markus att prioritera vad de ska utforska först.

Strukturen i den här sorteringsprocessen kan illustreras i figur 4.2.

Sättet på vilket man låter den andre välja är alltså att ställa en ny öppen fråga: ”Var ska vi börja?”, ”Vad är det viktigaste för dig att vi pratar om?” eller ”Hur vill du prioritera?”. Att ställa öppna frågor är ändamålsenligt både för att öppna situationen igen och för att uppmuntra den andre till att välja vad som ska diskuteras först.

Också under samtalets gång kan det vara ändamålsenligt att skapa en sådan öppen situation. Problem trasslar ofta ihop sig och har många aspekter, och det är inte nödvändigtvis lämpligt att sortera vid varje givet tillfälle. Men när olika problem dyker upp eller flyter samman kan det av och till



Figur 4.2 Att sortera problem.

vara bra att göra en kort sammanfattning, skapa en ny öppen situation och låta den andre välja: "Nu har vi talat lite om båda de här sakerna. Vad vill du fortsätta med?"

Hjälpsamhetens fallgrop

En vanlig fallgrop i situationer där den andre ska välja problem är att man som vårdpersonal känner ett behov att omedelbart kunna vara till hjälp. Man tar sig inte tid att i lugn och ro sortera upp problemen och låta den andre välja. Man börjar ställa frågor så fort man uppfattat ett problem. Några tycker också att det är svårt att märka skillnad mellan de olika problemen den andre presenterar och föredrar därför att gå rakt på. Även om det kan kännas lättare att börja fråga så snart man fått tag i något som verkar viktigt, och även om det kan ge en känsla av att få bättre kontroll över situationen, är det sällan till hjälp för den andre. Att sortera och låta henne eller honom välja problem är en professionell färdighet som också erfarna vårdare måste träna mycket på, innan de behärskar den.

Att hålla tråden

När problemet är valt, kan den andre ofta behöva lite hjälp att hålla tråden i samtalet. Detta kan med fördel göras utan att man dirigerar eller pressar. Viktiga färdigheter är att omformulera, upprepa nyckelord, ställa öppna frågor och uppmuntra att berätta vidare. Samtidigt följer man upp med aktivt lyssnande och bekräftande färdigheter, både verbalt och icke-verbalt.

Man kan också med fördel sammanfatta huvudpunkter eller viktiga sekvenser, eller få den andre att göra det: "Du har varit inne på lite olika saker. Vad var det viktigaste för dig i det som vi just har pratat om?"

Att plocka upp lösa trådar

I ett samtal kan det komma upp viktiga teman som bara berörs i förbifarten, eftersom det ofta är ett bestämt problem eller tema som står i centrum för uppmärksamheten. Kanske är patienten inte ens själv uppmärksam på temat, eller kanske kommer det bort längs vägen. En viktig strukturerande uppgift för vårdaren är att lägga märke till viktiga teman och bekymmer som dyker upp under samtalets gång, och som bara berörs indirekt eller inte blir tillräckligt belyst. Då kan man hjälpa den andre att komma tillbaka till detta innan tiden för samtalet är ute: "Du nämnde nyss att ...".

Att utveckla relationen och ge information

Att lyssna aktivt och återvända till teman som hittills berörts verkar starkt bekräftande, förutom att man på det viset kan få fram viktig information och stimulera till reflektion. Det visar att vårdaren är intresserad och följer med, bidrar till att den andre känner sig sedd och lyssnad på, och stärker därmed alliansen. Ett gyllene ögonblick kan skapas, där patientens mest viktiga frågor kommer upp i dagen (se kapitel 7, *Utforskande färdigheter*) och kan ge möjlighet att informera när patienten är som mest mottaglig.

I kärnan kan samtalet följa sin egen väg. Men det är samtidigt viktigt att passa tiden, så att man kommer in på det som är viktigast och är klar att avrunda när tiden för samtalet närmar sig sitt slut.

ÖVNING

Deltagare: Sjuksköterska/handledare och patient/student. De andra observerar. Fördela rollerna och bli eniga om en situation (den i bokens exempel eller något som ni väljer själva). Spela gärna in samtalet på video.

Sjuksköterskan/handledaren skapar en öppen situation och patienten/studenten presenterar flera problem samtidigt. Sjuksköterskan/handledaren lyssnar, delar upp, tydliggör och låter den andre välja problem. Låt dialogen utspela sig under några minuter.

Diskutera (eventuellt efter att ha tittat på videoinspelningen):

- Hur var det för sjuksköterskan/handledaren att ställa öppna frågor?
- Hur upplevde den andre att bli bemött på det sättet?

Observatörerna registrerar vilka frågor vårdaren ställde, uppdelningen av problemen och i vilken grad sjuksköterskan/handledaren lyckades skapa en ny, öppen situation.

Avslutningen

Fyra huvuduppgifter

Det är vårdarens uppgift att sörja för att samtalet kan avslutas på ett bra sätt inom den tidsram som har satts. Det innebär att man tar initiativ till att avsluta i god tid så att det också blir tid till att sammanfatta. Det betyder att det är för sent att ta initiativet till att avsluta när tiden är ute, som många gör, ofta med det resultat att avslutningen blir hastig och orolig.

När det närmar sig avslutning har vårdaren fyra huvuduppgifter:

- 1 att ta initiativ till en avrundning av samtalet
- 2 att låta den andre sammanfatta innehållet

- 3 att justera, om sammanfattningen inte täcker vad samtalen handlat om
- 4 att göra upp/bekräfta nya överenskommelser (tid/plats/innehåll för nästa möte).

Att ta initiativ till att avsluta

Ett sätt att ta initiativ till avslutning är att markera att samtalet närmar sig sitt slut, nämna de viktigaste poängerna som kommit fram i samtalet och sammanfatta förhållandevis kort. En sådan sammanfattning är inte bara början på en avslutning, utan också en integrerad del av samtalets process. Man kan till exempel göra på det här sättet:

SARA Nu har vi fem minuter kvar. Du har berättat att du upplever ansvaret som otydligt, att du inte riktigt vet vilka dina uppgifter är, och att personerna i ledningen är oeniga sinsemellan. Du har också sagt att du kände dig liten i situationen, och att du skulle önska att du inte hade varit ensam, utan tillsammans med någon som har mer erfarenhet. Det här är viktiga teman. Hur ska vi använda dom sista minuterna i dag?

En sådan sammanfattning ger den andre möjlighet att välja hur den återstående tiden ska användas. Många gånger kan en sådan preliminär sammanfattning bli en summering av känslan och innehållet i samtalet.

Men en sammanfattning mot slutet kan också vara konkret, repetera en instruktion som givits eller ta upp faktisk information. Här följer ett exempel på det, där en patient med svåra smärtor fått smärtlindrande mediciner:

LOTTA (vänder sig till patienten i sängen): Som sagt kan det nog ta lite tid, en halvtimme eller tre kvart, innan du kommer att känna effekten av tabletterna och dina smärtor blir lite lindrigare. Jag kommer in om en stund. Om du vill få tag i mig tidigare, är det bara att du trycker på knappen här.

Poängen är att sammanfatta det väsentligaste och ge den andre möjlighet att reagera på detta – att bekräfta eller korrigera. Det bidrar både till att man utvecklar en gemensam förståelse och till att den andre känner sig sedd och lyssnad på.

Låt den andre sammanfatta

En viktig funktion i avslutningen är att den andre sammanfattar vad hon eller han har förstått av samtalet. Det är inte samma sak som att hålla med om den sammanfattning som vårdaren ger. Viktigt är att den andre formulerar sina insikter med egna ord och inte får ord lagda i munnen. Det här är både en hjälp för den andre till att tänka igenom vad i samtalet som har varit det väsentliga för henne eller honom, och en möjlighet för vårdaren att fylla ut eller korrigera bilden om detta skulle bli nödvändigt.

Det är alltså viktigt att hålla följande två funktioner åtskilda från varandra:

- att bekräfta den andre genom att sammanfatta
- att få henne eller honom att bekräfta sina insikter genom att själv sammanfatta det viktigaste.

Vårdaren kan bidra till en sådan reflektion genom att fråga vad den andre upplever som det viktigaste, till exempel så här:

PER Karin, nu har jag sammanfattat hur jag har uppfattat en del av det som vi pratat om i dag. Om du skulle sammanfatta det du upplever som det viktigaste, hur skulle du då formulera det?

I den här situationen kan vårdaren riskera att få bollen tillbaka, exempelvis i form av att den andre helt enkelt håller med om det som just sagts:

”Jag är helt överens med dig om det som du nyss sa.”

Då är det viktigt att inte låta nöja sig med det, utan låta ansvaret ligga kvar hos den andre. Exempelvis genom att spela tillbaka bollen:

”Ja, jag förstår det. Men om du skulle formulera det viktigaste på ditt eget sätt, hur skulle du då säga det?”

Vårdaren bör då låta bli att försöka hjälpa patienten, exempelvis genom att aktivt använda pauser till dess att hon eller han delar med sig av sina reflektioner.

Korrigera om det behövs

Poängen är alltså att få den andre att visa att hon eller han har förstått. Att formulera de egna insikterna är ett sätt att skapa och befästa förståelse, samtidigt som det ger vårdaren möjlighet att kommentera, korrigera och utveckla förståelsen ytterligare. Och det lägger en gemensam grund att gå vidare. Dessutom bidrar det till att ansvaret för situationen förblir hos patienten.

Göra upp nya avtal

Avslutningsvis i samtalet avtalar man om tid och plats för nästa möte. Det kan vara en fördel om vårdaren är förberedd och har konkreta förslag på förhand. Även om det redan har avtalats, är det viktigt att vårdaren avslutningsvis nämner tid och plats och därmed sätter punkt för samtalet.

En fördel med detta är att nya överenskommelser – för patienter som behöver detta – kan bidra till att bekräfta relationen, skapa framtidsperspektiv och stärka tilltron till att det kommer att gå åt rätt håll. Något så praktiskt som att göra upp avtal och bekräfta dessa i avslutningen av ett samtal kan med andra ord också bidra till att stärka patientens hopp och copingförmåga.

Samtalets komplexitet

Dialoger med patienter och anhöriga är komplexa, och samtal kan vara av mycket olika karaktär. Ett slags samtal, som ställer särskilda krav på vårdarens förmåga att strukturera det, är när man måste förmedla dåliga nyheter. Vi kommer tillbaka till detta i kapitel 8, *Informerande färdigheter*. Dialogen ”Ska jag bara ge mig i väg nu då?” kan illustrera både samtalets komplexitet generellt och vad som behövs för att en öppning och en avslutning av ett krävande samtal ska lyckas.

Att strukturera ett samtal på ett bra sätt efter alla moment vi nämnt här är idealiskt, något som vi rekommenderar att man försöker uppnå. Men det kräver träning och uppmärksamhet. Att slaviskt följa en modell som den vi har presenterat är emellertid ingen bra lösning. Det viktigaste är kanske att vara medveten om betydelsen av att strukturera samtalet, att lyssna aktivt och följa den andre under samtalets gång – och att sörja för att samtalet avslutas så att det viktigaste tas om hand på ett bra sätt. Då blir som regel även helheten bra.